

Надрез бляшки с трансплантацией

Информация для пациента · Операция по выпрямлению полового члена (болезнь Пейрони)

WARWIKI

При болезни Пейрони рубец (бляшка) внутри полового члена вызывает его искривление при эрекции, что может затруднять половой акт. В ходе операции рубец на укороченной стороне надрезают (иногда частично удаляют), устраняя изгиб, а образовавшийся дефект закрывают трансплантатом. Это руководство объясняет, как проходит процедура, как к ней подготовиться и чего ожидать.

Об этой операции

Рубцовая бляшка стягивает одну сторону полового члена, вызывая искривление при эрекции. Операция устраняет изгиб, рассекая рубец на **укороченной (внутренней) стороне**; образовавшийся дефект заполняют **трансплантатом** — тонкой заплаткой (коллагеновый патч, донорская/животная ткань или ткань вашего собственного тела). Поскольку удлиняется короткая сторона, а не укорачивается длинная, **длина полового члена сохраняется**.

Операция показана, когда:

- Искривление **выраженное или сложное** (например, форма песочных часов или «петли»)
- Важно сохранить **длину** (пликация даст слишком большое укорочение)
- **Эрекция достаточно хорошая** для выполнения этой операции

Что важно знать

Преимущество — **длина сохраняется** (иногда незначительно увеличивается). Компромисс — **более высокий риск новых или усугубившихся проблем с эрекцией** по сравнению с пликацией: работа с рубцом может нарушить кровенаполнение. Поэтому операцию предлагают только при хорошей эректильной функции. **Онемение головки** полового члена после операции — обычное явление (нервы аккуратно смещаются во время вмешательства) и, как правило, проходит за 6–12 месяцев. Большинство пациентов достигают прямой эрекции, достаточной для секса.

ТЕРМИНЫ

Болезнь Пейрони

Рубец в половом члене, вызывающий его искривление при эрекции.

Бляшка

Участок рубцовой ткани, ответственный за искривление.

Трансплантат (графт)

Тонкая заплатка для закрытия дефекта после рассечения рубца — коллагеновый патч, донорская/животная ткань или собственная ткань пациента.

Искусственная эрекция

Эрекция, создаваемая в операционной (с помощью инъекции) для измерения и оценки степени искривления.

Обрезание

Удаление крайней плоти — нередко выполняется одновременно, если ранее не проводилось.

Пенильная реабилитация

Использование таблеток для эрекции и/или вакуумного устройства в период заживления для защиты эрекции и сохранения длины.

Общая анестезия

Препарат, погружающий вас в сон и устраняющий боль во время операции.

БУДЕТ ЛИ БОЛЬНО? Операция проводится под общей или спинальной анестезией, поэтому вы ничего не почувствуете. После неё ожидайте отёка, синяков и болезненности полового члена в течение 1–2 недель — помогают лёд, поддерживающее бельё и обезболивающие. Операция длится дольше пликации (обычно 1,5–3 часа); возможна госпитализация на одну ночь. Катетер, как правило, удаляют на следующее утро.

Как подготовиться (до операции)

- Операция проводится под **общей или спинальной анестезией** — выполняйте все хирургические рекомендации (голодание, отмена лекарств, включая антикоагулянты).
- Болезнь Пейрони должна быть **стабильной** (искривление и боль не менялись несколько месяцев), а **эрекция заранее оценена** — хорошая эректильная функция обязательна.
- Не курите**; любую инфекцию сначала лечат; перед операцией вы получите антибиотики. При необходимости обрезание выполняют одновременно.

Сообщите команде заранее, если вы:

- Имеете **слабую эрекцию** или нуждаетесь в таблетках/инъекциях для её достижения
- Принимаете антикоагулянты или ранее перенесли операцию на половом члене

Как проходит операция

- 1 Вы находитесь под анестезией; вводятся антибиотики.
- 2 **Инъекцией создаётся эрекция** для оценки искривления; кожа отводится, нервы на поверхности полового члена аккуратно смещаются.
- 3 Рубец на укороченной стороне **надрезают (иногда частично удаляют)**, дефект закрывают **трансплантатом**; результат проверяют и рану ушивают.

После операции

- Ожидайте **отёка, синяков и болезненности** 1–2 недели. **Онемение головки** — обычное явление, как правило проходит за несколько месяцев.
- Катетер обычно удаляют на следующее утро.
- Избегайте секса около 6–8 недель**, чтобы трансплантат прижился.
- Врач, скорее всего, назначит **пенильную реабилитацию** — низкодозовый препарат для эрекции и/или ежедневное вакуумное устройство — для защиты эрекции и сохранения длины.

Обратитесь к врачу, если у вас:

- Повышение температуры или озноб, нарастающее покраснение, боль, отёк или выделения из раны
- Невозможность помочиться
- Сильная или усиливающаяся боль/отёк либо обильное кровотечение

ТРИ ВАЖНЫХ МОМЕНТА

1. Операция устраняет искривление, рассекая рубец на укороченной стороне и закрывая дефект трансплантатом — **длина сохраняется**; показана при выраженных или сложных деформациях.
2. Компромисс — **более высокий риск проблем с эрекцией** по сравнению с пликацией; раннее онемение головки обычно проходит.
3. Болезнь должна быть стабильной, эрекция — оценена; не курите. После операции избегайте секса ~6–8 недель и следуйте программе реабилитации.